

Mandatsnotiz und Fristsache

Mandantin: Helga Bertram, geboren 22.05.1964, Münster-Hiltrup. Beschäftigt als Küchenhilfe in einer Schulkantine, 24 Wochenstunden. Bekannter GdB 30 seit 2021 wegen Diabetes mellitus mit Polyneuropathie und Wirbelsäulenbeschwerden. Erhöhungsantrag vom 04.03.2026. Bescheid Stadt Münster vom 21.06.2026, Zugang 25.06.2026: GdB weiterhin 30, Merkzeichen G abgelehnt. Widerspruchsfrist bis 25.07.2026.

Neue gesundheitliche Entwicklung: diabetische Polyneuropathie mit brennenden Fußschmerzen, COPD Gold II mit Belastungsdyspnoe, Kniearthrose rechts, rezidivierende depressive Anpassungsstörung. Mandantin kann nach eigenen Angaben maximal 300 bis 400 Meter gehen, braucht dann Pause. Der Hausarzt befürwortet GdB 50 und Merkzeichen G, das Versorgungsamt stützt sich im Wesentlichen auf kurze Befundantworten ohne aktuelle Lungenfunktionswerte.

Ziel: Widerspruch mit Akteneinsicht und gezielter Nachreichung von Befunden. Nicht vorschnell nur Diagnosen addieren; entscheidend sind Funktionsbeeinträchtigungen, Teilhabefolgen, Gehfähigkeit, Schmerz, Atemnot, Arbeitsplatzbelastung und Konsistenz der ärztlichen Angaben.

Bescheid GdB-Erhöhung und Merkzeichen

Stadt Münster, Amt für Soziales und Wohnen. Bescheid vom 21.06.2026.

Sehr geehrte Frau Bertram,

Ihren Antrag auf Neufeststellung nach Paragraph 152 SGB IX lehnen wir ab. Der Grad der Behinderung beträgt weiterhin 30. Die Voraussetzungen für das Merkzeichen G liegen nicht vor.

Berücksichtigt wurden folgende Funktionsbeeinträchtigungen: Diabetes mellitus mit nervalen Beschwerden, Wirbelsäulenbeschwerden, Atemwegsbeschwerden, Kniegelenksbeschwerden. Nach Auswertung der ärztlichen Unterlagen ergibt sich keine wesentliche Verschlimmerung gegenüber der letzten Feststellung. Die Gehfähigkeit ist nicht in einem für das Merkzeichen G erforderlichen Ausmaß eingeschränkt.

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erheben.

Befundbericht Hausarzt Dr. Büscher

Frau Bertram ist seit vielen Jahren in hausärztlicher Behandlung. Der Diabetes ist trotz Insulintherapie wechselhaft eingestellt. Seit Ende 2025 berichten wir eine deutliche Zunahme neuropathischer Beschwerden beider Füße mit Brennen, Taubheit und Gangunsicherheit. Die Patientin vermeidet längere Wege und setzt sich bei Einkäufen häufig hin.

COPD Gold II, letzte Spirometrie 16.05.2026 mit FEV1 58 Prozent des Sollwertes. Belastungsdyspnoe bei Treppen und schnellerem Gehen. Zusätzlich Kniearthrose rechts mit Schwellneigung nach Belastung. Schmerzmedikation Pregabalin abends, Metamizol bei Bedarf. Nebenwirkungen: Müdigkeit und Benommenheit am Morgen.

Aus meiner Sicht ist der bisherige GdB 30 zu niedrig. Die Kombination aus Polyneuropathie, COPD und Kniearthrose führt im Alltag zu einer erheblichen Einschränkung der Gehfähigkeit. Eine fachärztliche neurologische und pneumologische Ergänzung ist sinnvoll.

Neurologischer Bericht

Neurologische Praxis Dr. Aylin Stern, Bericht vom 10.06.2026. Klinisch: distal symmetrische Sensibilitätsminderung beider Füße, abgeschwächte Achillessehnenreflexe, unsicherer Zehen- und Fersengang, positives Romberg-Zeichen bei Augenschluss. Elektroneurographie zeigt Hinweise auf sensomotorische Polyneuropathie, vereinbar mit diabetischer Genese.

Die Patientin schildert brennende Schmerzen ab spätem Nachmittag, nachts Kribbeln und Einschlafstörungen. Sturzereignis am 18.04.2026 auf dem Weg zur Bushaltestelle, Hämatom Knie rechts. Gehstrecke nach eigener Angabe 300 Meter ohne Pause, bei Kälte weniger. Objektiv im Praxisflur verlangsamtes Gangbild, vorsichtig, ohne Hilfsmittel.

Empfehlung: Optimierung Diabeteseinstellung, Podologie, Schmerztherapie, Prüfung Gehstock. Für die sozialmedizinische Bewertung sollten Gangunsicherheit und neuropathischer Schmerz nicht getrennt von COPD und Kniearthrose bewertet werden.

Pneumologischer Befund

Pneumologiezentrum Münster, 18.05.2026. Diagnose: COPD Gold II, Ex-Raucherin seit 2022, Belastungsdyspnoe mMRC 2 bis 3. Spirometrie: FEV1 58 Prozent Soll, FEV1/FVC 61 Prozent, geringe Reversibilität. Sauerstoffsättigung Ruhe 95 Prozent, nach sechs Minuten Gehstest Abfall auf 91 Prozent. Gehstrecke im Sechs-Minuten-Test 298 Meter, Abbruch wegen Atemnot und Fußschmerzen.

Therapie: Inhalation LABA/LAMA, Bedarfsspray, Atemphysiotherapie empfohlen. Keine Langzeitsauerstofftherapie. Die Belastbarkeit ist gegenüber 2024 reduziert. Treppensteigen in den ersten Stock nur mit Pause.

Arbeitsplatznotiz Schulkantine

Arbeitgeber Schulverpflegung Westfalen gGmbH, Notiz Teamleitung vom 27.06.2026. Frau Bertram arbeitet in der Spülküche und Ausgabe. Seit Frühjahr 2026 kann sie Getränkekisten nicht mehr tragen und bittet häufiger um Sitzpausen. Wege zwischen Lager und Ausgabe dauern länger. Bei Treppen zum Kellerlager wird sie nicht mehr eingeteilt. Stehen über 30 Minuten führt zu sichtbaren Schmerzen. Bei hoher Luftfeuchtigkeit klagt sie über Atemnot.

Der Arbeitgeber versucht, sie weiter einzusetzen, weil sie zuverlässig ist. Eine Reduzierung auf reine Kassentätigkeit ist nicht möglich, weil alle Küchenhilfen wechseln müssen. Krankheitsbedingte Ausfälle 2026 bisher 21 Arbeitstage.

Alltagsprotokoll Gehfähigkeit

12.06.2026: Weg zur Bushaltestelle 380 Meter. Nach etwa 250 Metern Pause an Gartenmauer. Füße brennen, rechte Wade krampft. Bus fast verpasst.

14.06.2026: Einkauf im Supermarkt mit Wagen als Stütze. Nach 20 Minuten Atemnot, an der Kasse gesetzt. Zu Hause eine Stunde Beine hoch.

18.06.2026: Treppe zu Schwester im zweiten Stock nicht geschafft. Nach erstem Stock Pause auf Treppenabsatz, Schwester kam herunter.

22.06.2026: Arbeit in der Kantine, Spüldienst nach 35 Minuten getauscht. Teamleitung sagte, ich solle nicht wieder stürzen.

26.06.2026: Bescheid gelesen. Verstehe nicht, warum die Lunge und Füße einzeln so klein gerechnet werden. Angst, die Arbeit nicht bis Rente zu schaffen.

Widerspruchsentwurf

Sehr geehrte Damen und Herren,

gegen den Bescheid vom 21.06.2026, zugegangen am 25.06.2026, lege ich namens und im Auftrag von Frau Helga Bertram Widerspruch ein.

Der Bescheid bewertet die Funktionsbeeinträchtigungen nicht ausreichend. Es geht nicht um eine bloße Addition einzelner Diagnosen, sondern um die Gesamtwirkung aus diabetischer Polyneuropathie, COPD, Kniearthrose und Schmerzmedikation. Frau Bertram ist in ihrer Gehfähigkeit erheblich eingeschränkt. Der pneumologische Sechs-Minuten-Test ergab nur 298 Meter mit Abbruch wegen Atemnot und Fußschmerzen. Der neurologische Bericht beschreibt Gangunsicherheit, Sensibilitätsminderung und neuropathischen Schmerz. Der Arbeitsplatzbericht bestätigt erhebliche Einschränkungen beim Stehen, Tragen, Gehen und Treppensteigen.

Es wird Akteneinsicht beantragt, insbesondere in die versorgungsärztliche Stellungnahme. Ergänzend werden die Befunde von Dr. Büscher, Dr. Stern und dem Pneumologiezentrum Münster eingereicht. Nach Akteneinsicht bleibt eine weitere Begründung vorbehalten.

Beantragt wird die Feststellung eines GdB von mindestens 50, hilfsweise eine erneute Begutachtung, sowie die Prüfung des Merkzeichens G.

Befundanforderungsliste

Hausarzt: vollständige Diagnosenliste, Medikamentenplan, Diabetesverlauf, Sturzereignisse. Neurologie: Elektroneurographie, Gangprüfung, Schmerzmedikation, Prognose. Pneumologie: Lungenfunktion, Sechs-Minuten-Test, mMRC-Einstufung, Therapieplan. Orthopädie: Kniearthrose, Wirbelsäule, Geh- und Stehfähigkeit. Arbeitgeber: konkrete Tätigkeiten, Ausfälle, Anpassungen, Treppen/Lager/Spüldienst. Mandantin: Wegeprotokoll, Fotos von Hilfsmitteln, Nachweis Sturz, Fahrkarten oder Taxi quittungen falls vorhanden.

Klagestrategie Sozialgericht

Wenn der Widerspruch erfolglos bleibt, sollte die Klage die Teilhabewirkung konkret beschreiben. Schwerpunkt ist die Gehfähigkeit: nicht abstrakte Diagnose, sondern Weg zur Arbeit, Supermarkt, Treppen, Pausen, Sechs-Minuten-Test, Sturz und Arbeitsplatzanpassung. Für das Merkzeichen G müssen die tatsächlichen Einschränkungen im Straßenverkehr und bei üblichen Wegen präzise dargestellt werden.

Mögliche Beweismittel: versorgungsärztliche Stellungnahme angreifen, behandelnde Ärzte als sachverständige Zeugen, Einholung eines internistisch-neurologischen Gutachtens, Arbeitgeber als Zeuge für Steh- und Gehprobleme. Parallel prüfen: Altersrente für schwerbehinderte Menschen, wenn GdB 50 rechtzeitig festgestellt wird.

Datei: 10_fristen_und_anlagen.csv

Ereignis	Datum	Notiz
Erhöhungsantrag	2026-03-04	GdB und Merkzeichen G
Bescheid	2026-06-21	GdB 30 Merkzeichen abgelehnt
Zugang	2026-06-25	Briefkasten
Widerspruchsfrist	2026-07-25	ein Monat
Hausarztbericht	2026-06-28	liegt vor
Neurologie	2026-06-10	liegt vor
Pneumologie	2026-05-18	liegt vor
Arbeitsplatznotiz	2026-06-27	liegt vor
Akteneinsicht beantragen	2026-07-05	offen